C.真性红细胞增多症
D.脾切除术后 ①没有脾脏破坏血小板,血小板↑容易生成血栓②术后需长期卧床

9.2025N96-97 A 男性，68 岁。阵发性下腹痛 1 周，加重 3 天伴停止排气排便来诊。既往体健。查体：BP 130/80mmHg。腹部膨隆，全腹压痛，下腹部为重，无肌紧张，肠鸣音亢进。化验：血 WBC 12×10^9/L，腹部 X 线平片提示小肠扩张，多发气液平。

96.最可能的诊断是
A.上消化道穿孔
B.机械性肠梗阻
C.重症急性胰腺炎
D.急性化脓性阑尾炎

97.下列检查方法中不宜采用的是
A.腹部 CT
B.钡剂上消化道造影 钡餐禁忌症:①消化道穿孔②完全性梗阻
C.结肠镜
D.钡剂灌肠

思维导图·肠梗阻

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

	小肠扭转	乙状结肠扭转
方向	顺	逆
好发	青年	老年
看主诉	饱餐+运动等体位改变	便秘+运动等体位改变
关注原发部位	脐周绞痛	左下腹绞痛
呕吐	早、频繁	不明显、晚期可少量粪样物
腹胀	以某处特别明显	全腹明显者、左下腹更明显
排便排气	完全性则停止	
肠鸣音	亢进,若坏死则减弱消失	
影像	CT最佳(空回肠换位征) 漩涡征 (排列成多种形态的小跨度蜷曲肠袢)	钡灌肠鸟嘴征(兼复位治疗) 马蹄状巨大双腔充气肠袢 阶梯状液气平、结肠袋形
最基本治疗	禁食补液、胃肠减压	
最重要治疗-及早手术	回转复位扭转的肠袢	
(闭袢易绞窄)	若坏死→肠段切除 (腹膜刺激征)一期吻合	若坏死→肠段切除 (腹膜刺激征) 造口